جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : فاطمه زكى الوصال الديب
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الساحل **العنوان :** /////
رقم البطاقة : 26903281600182 **رقم التليفون :** 01069286079 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 28-03-1969 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: فاطمه زكي الوصال الديب
National ID: 26903281600182

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



فاطمه
زكى الوصال الديب
١٧ ش الحرية-ش التبريدات
الساحل - القاهره

٢٦٩٠٣٢٨١٦٠٠١٨٢

١٩٦٩/٠٣/٢٨

KN3468873

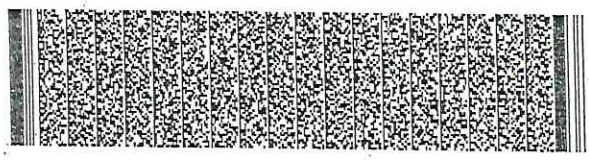
٠١٠١٤٢٩١٠٧١
٠١٠٩٦٠٥٧٠٠١

٢٦٩٠٣٢٨١٦٠٠١٨٢ ٢٠٢٤/٠٥

بدون عمل

أنثى مسلمة أرملة

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٥/١٠



National ID · Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: فاطمة زكي الوصال	
MR. : 4160	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

56 Y POSTM RECURRENT METACHRONOUS LEFT BREAST CANCER UNDERGONE LEFT MRM 7/2025 PT2 N12/11TRIPLE NEGATIVE MDT AC TAXOL CARBO RT MRM 2000 REC ADJ CHEMO RT HT TO OMMIT AC

FOR W1 TAXOL 160 MG CARBOPLATIN AUC 5 WT96 HT170 SA2 W231/1TAXOL W37/2 TAXOL

FOR W1 TAXOL 160 MG CARBOPLATIN AUC 5 WT96 HT170 SA2 W231/1TAXOL W37/2 TAXOL 24/1 NOT RECIEVED

clinical pharmacy note : for w2 taxol 160 mg and next week for w3 taxol on 2/3 pharmacy pt. received carboplatin auc5 on w1

PT IS FEVERISH E GENERALISED PAIN FOR CBC AND CRP AND POST PONE THE CYCLE

w3 taxol 135 mg CARBO 1.5 AUC and next week for w4 W5 PHARMACY taxol DR 15 % PT JUST RECOVERY FROM CHEST INFECTION

pt had chest infection 1 m ago .ct chest 3/2026 multiple bilat pulmonary nodules likely metasta .ct8/4/2026 multiple bilateral consolidation and cavitations for pet ct for abg normal crp 123 for chest consultation pet ct mdtand fu afer 1 week after supp tt

CT CHEST 4/2026 = multiple bil pulm cavitating nodules + consolidations lgt cavitating nodule 27/x19 mm at left upper lobe + mediastinal LN 21/x18 mm precarinal follow up PET or NCCT CHEST depending on approvals, for new CRP to determine whether to receive cycle today

chest infection improved for new cts if pet ct not available .mdt pending for w5 taxol 160 carbopl auc 2 crp decreased 11

NCCT CHEST 5/3/2026 - Right middle and lower lobar consolidation with air bronchogram likely pneumonia, Bilateral scattered pleural based nodules the largest seen on the left upper lobe measuring 16 x 12 mm, No sizeable hilar or mediastinal lymphadenopathy.. CT CHEST 8/4/2026 = multiple bil pulm cavitating nodules + consolidations lgt cavitating nodule MEASURING 27x19 mm at left upper lobe + mediastinal LN 21x18 mm

new pet ct or new cts pending for w7 taxol 160 carbopl auc 2 and solucortef avil before mdt pending

for w8 TC, labs last week , pt still c/o of productive cough .. still pending new assessment

inflammed portcath cc vertigo for mri brain new cts

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

cts + mri brain still pending to continue her ttt for w8 TC after labs w9 + w10 at pharmacy

pending scans, today for w11 TC, after labs, pending, w12 pharmacy

cts 26/8/2026 bilat pulmonary nodules 5.7 mm splenic focal lesion med ln 17x14 ,(last cts rt middle and lower lobe consolidative changes pulmonary nodules 16x12 mm) mri brain free cc grade 2 pn for 20% dr for comp of cts to be sure this nodules is metastatic or not and acc plan of tt for w12 taxol 130 carbopl auc 2 methyltechno

The patient has completed 12 weeks of taxol and carboplatin therapy to date.

GUSTAVE ROUSSY

د / عبد الرحمن سمان
١٠٦٩٢٨٦٠٧٩

Patient Name	: الأستاذه / فاطمه زكي الوصال	Request No.	: 13002154
Patient No.	: 26903281600182	Request Date	: 08/11/2025
Path No.	: SR-1577/25	Verification Date	: 15/11/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data
Breast mass.

Nature of specimen
Block revision

Gross examination
One paraffin block labelled (535) was received
Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against: HER2/NEU (4B5),KI67 (30-9), PR (1E2), ER (SP1).

Microscopic examination
* Histological type: Extenisvely autolytic breast carcinoma
* DCIS: Absent
*Lobular intra epithelial neoplasia : Absent
* Angioinvasion: Absent .
* Microcalcification :Absent.
*Perineural invasion: Absent
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
* ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
* PR:No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
* HER2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)

Diagnosi

Verified by :
Dr.Heba Hasan

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

ant Name	: الأستاذه / فاطمه زكي الوصال	Request No.	: 13002154
dient No.	: 26903281600182	Request Date	: 08/11/2025
ath No.	: SR-1577/25	Verification Date	: 15/11/2025
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 56 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

BREAST MASS, BLOCK REVISION :
-Extensively autolytic breast carcinoma
IPT:
* ER: Negative (score 0/8).
* PR: Negative (score 0/8).
* HER2: Negative (score 0)
-ER, PR, HER2 are with good control.
-Comment :Severe autolysis can affect the IHC profile results , so refer to the core results for better evaluation .
* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
* Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Dr.Walaa Ibrahim Ghonelm
Dr.Heba El-Shafeey

Verified by :
Dr.Heba Hasan

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

٤١٦٠

جوستاف زوسي

Patient's Name:	**Fatima Zaki Al-Wesal Al-Dib**
Date:	**2026-08-26**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA underwent bilateral MRM.

I- CHEST:

- Porta cath is noted.
- Right upper lobe subpleural reticulations likely post radiation sequelae.
- Few bilateral scattered pulmonary nodules largest measuring 5.7 mm at the right upper lobe.
- Multiple bilateral scattered emphysematous bullae.
- No pulmonary masses.
- No consolidation or collapse.
- Few mediastinal lymph nodes largest measuring 17 x 14 mm at the precarinal region.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Average sized spleen showing hypodense focal lesion measuring 9.6 x 8 mm.
- Small gall bladder calculus.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Mesenteric panniculitis with multiple subcentimetric mesenteric lymph nodes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Few bilateral external iliac subcentimetric lymph nodes.
- No ascites.

Opinion:

- **Few bilateral scattered pulmonary nodules.**
- **Splenic focal lesion for MR assessment.**

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy